

06 - 06- Radiculalgie des membres - Pr Niamane

Bonjour, on va voir maintenant un cours sur les radiculergies des membres. Alors dans ce cours, mes objectifs pédagogiques sont les suivants. Il faut savoir diagnostiquer une radiculergie, connaître la topographie de cette atteinte radiculaire, savoir distinguer par la clinique la radiculergie commune de la radiculergie symptomatique, connaître les étiologies des radiculergies, identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge, proposer une attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.

Alors que ce que c'est qu'une radiculergie ? Une radiculergie se définit comme étant la souffrance d'une racine nerveuse à l'origine d'une douleur de topographie radiculaire quelle que soit son étiologie. Il y a deux particularités qu'il faut retenir. La première particularité, c'est qu'une atteinte radiculaire se manifeste sur le plan clinique par sa topographie métamérique, c'est-à-dire qu'une atteinte du racisme cervical va être responsable de ce qu'on appelle une névralgie cervicobraquia, c'est-à-dire une atteinte des racines qui émergent du trou de conjugaison du racisme cervical avec une topographie métamérique au niveau du membre supérieur.

Au niveau du racisme dorsal, on les appelle les névralgies intercostales, ils sont très rares. Et au niveau du racisme lombaire, ce sont des radiculergies du membre inférieur qui touchent le nerf sciatique, on les appelle une lombo-sciatique ou bien le nerf curale, on les appelle les lombo-curalgiques. La deuxième particularité, c'est qu'il existe deux formes cliniques et de pronostics complètement différents, les radiculergies communes qui représentent de loin l'étiologie la plus fréquente et qui sont en rapport soit avec une hernie discale soit avec de l'arthrose au niveau du racisme, et les radiculergies symptomatiques qui sont heureusement rares et qui sont symptomatiques d'une pathologie néoplasique ou infectieuse le plus souvent.

Pour le rappel anatomique, vous connaissez parfaitement qu'il y a trois segments rachidiens, il y a le segment cervical avec 7 vertèbres, le segment thoracique avec 12 vertèbres, le segment lombaire avec 5 vertèbres, je ne compte pas ici le sacrum et le coccyx. Alors les racines nerveuses, comme vous voyez, la racine émerge par le trou du congélisant et porte le nom de la vertèbre sous-jacente. Donc une racine C6 émerge de l'espace intervertébral C5 C6, donc il porte le nom de la vertèbre sous-jacente.

Ça c'est très important pour faire la corrélation entre la radiculergie qu'on présente au patient et l'étage qui y est atteint. Chaque radiculergie va donner une douleur topographie bien systématisée qu'on appelle les dermatomes, ce qui permet à l'examen clinique de remonter vers l'étage qui est atteint en fonction de votre examen clinique, surtout lorsque vous avez du trouble de la sensibilité tactile à l'examen neurologique. Alors on voit très très bien qu'il y a des rapports qui sont vraiment très étroits entre la racine nerveuse et le trou du congélisant.

On voit bien que la racine nerveuse a un contact très rapproché du disque intervertébral et souvent lorsque ce disque intervertébral qui va subir des lésions dégénératives entre

parenthèses d'usure qui apparaissent avec le temps, on voit qu'ils peuvent être responsables d'arthrose, ce qu'on appelle la disque arthrose qui est la tête dégénérative du disque intervertébral, parfois de hernies discales et ces hernies discales vont comprimer la racine nerveuse et être à l'origine des radiculinges. Donc vous voyez ici sur une coupe cadavérique longitudinale, on voit à droite les corps vertébraux, le disque intervertébral qui joue le rôle d'amortisseur qui est tout à fait de structure normale avec ses fibres périphériques fibreuses qui est le nucleosis fibrosus et à l'intérieur nous avons cette sorte de gélatine que le nucleosis pulposus qui va quand il sort, quand il quitte le disque intervertébral à travers une fissure, il va être au contact de la racine nerveuse ce qui définit la hernie discale. On voit bien sur les trous de conjugaison d'où émergent les racines nerveuses et vous avez le canal rachidien, donc ça c'est une coupe qui va montrer que les racines nerveuses sont en étroit contact avec les racines nerveuses.

Donc à gauche vous voyez sur une coupe cadavérique le disque intervertébral normal, à droite vous voyez un disque intervertébral qui a subi une dégénérescence, un vieillissement en quelque sorte et vous voyez sur la droite le nucleosis pulposus qui a quitté le disque intervertébral à travers une fissure au niveau du noyau fibrosus et sur l'agrandissement on le voit en contact avec la racine nerveuse et il va donner une hernie discale. Donc sur cette diapositive, ce qu'il y a à gauche c'est la dégénérescence disco-vertébrale qui est responsable de l'arthrose, de la cervico-arthrose, la cervico-arthrose peut donner une névralgie cervico-brachiale, de la lombo-arthrose qui va être responsable soit d'une lombo-cyliatrique soit d'une lombo-chirurgie, à droite nous sommes devant un tableau de hernie discale qui est défini par l'issue du noyau pulpeux et qui va être en contact avec la racine nerveuse et qui va donner la même symptomatologie, une névralgie cervico-brachiale lorsque la tête est située au niveau de la racine cervicale, une lombo-cyliatrique ou une lombo-chirurgie lorsqu'il s'agit du ventre inférieur. Alors dans les deux cas, il s'agit d'une lombo-radiculalgie commune.

Alors comment est-ce qu'on explique la physiopathologie de la douleur radiculaire ? Alors la racine va souffrir de deux manières, soit de l'agression mécanique, en fait c'est la compression par l'arthrose, le plus souvent par la hernie discale ou par des facteurs chimiques. Donc des facteurs mécaniques. Alors ici la racine est comprimée par la hernie discale ou par des ostéophytes lorsqu'il s'agit d'une disque arthrose ou elle peut être comprimée par un autre processus, une tumeur ou un abcès lorsqu'il s'agit d'une lombo-radiculalgie symptomatique.

Alors cette compression va être à l'origine du trouble de la circulation au niveau de la racine nerveuse ou bien il peut s'agir d'une irritation directe de cette racine. Il faut savoir que la compression durable entraîne une ischémie radiculaire et on sait bien que le tissu nerveux est très sensible à l'ischémie avec une réduction du nombre des grosses fibres sensitives qui peut parfois être responsable de la persistance du douleur neurologique chronique même après la levée de l'obstacle. Ici l'exemple d'une hernie discale qu'on va opérer trop tardivement, même si le chirurgien enlève la hernie discale, le malade peut garder malheureusement du douleur

neuropathique chronique parce que cette racine a été victime d'une ischémie radiculaire pendant longtemps.

Le facteur chimique est expliqué essentiellement par l'apparition de lésions inflammatoires lorsque le nucléus pulposus ou bien l'ostéophyte est en contact de la racine nerveuse avec une sécrétion localement d'un certain nombre de médiateurs de l'inflammation ce qui explique en quelque sorte l'effet bénéfique des anti-inflammatoires, la cyclooxygénase c'est que lorsqu'on bloque les anti-inflammatoires en stéroïdes ou bien la phospholipase qu'on peut bloquer par les corticoïdes. Donc l'effet bénéfique de ces bioclasses thérapeutiques dont les radiculalgies bien sûr communes. Alors maintenant on passe à la prise en charge.

Donc il faut réfléchir étape par étape. La première étape étant de faire le diagnostic, c'est à dire qu'il faut connaître les caractères généraux et communs de la radiculalgie, d'abord par l'interrogatoire. Ici le maître symptôme étant la douleur, il faut bien sûr caractériser sa durée, son siège, son intensité, sa topographie exacte, le rythme, ce qui est le mécanisme inflammatoire, la cause déclenchante et le terrain.

Il y a deux types de douleurs. Il y a la douleur d'abord au niveau du rachis, donc c'est une douleur qui a un mécanisme annexé de nos réceptions, donc qui associe la rachialgie et la raideur. Donc pour le rachis cervical, c'est la cervicalgie et la raideur.

Pour le rachis lombaire, c'est la lombalgie et la raideur. Le deuxième type de la douleur, c'est la douleur radiculaire qui est une douleur de type neuropathique. Et l'analyse symptomatologique de la douleur radiculaire est primordiale pour faire le diagnostic de la péralgie.

Alors la douleur neuropathique, elle est de deux types. Soit nous avons des sensations douloureuses, soit des sensations non douloureuses. Les sensations douloureuses sont de deux types et peuvent être continues, superficielles à type de brûlure, ou bien profondes avec une sensation d'arrachement ou de brouillement que le malade arrive difficilement à décrire au médecin.

Les douleurs paroxystiques sont décrites par le patient comme étant des décharges électriques ou une sensation d'éclair Les sensations non douloureuses, alors ces sensations douloureuses, en fait, c'est cet aspect désagréable que décrit le patient à type de fourmillement, de picotement ou d'engourdissement. Et ces sensations non douloureuses peuvent être spontanées ou provoquées par l'examen clinique lorsqu'on touche le patient. L'examen clinique, alors l'examen clinique il faut s'intéresser à trois éléments.

L'examen clinique, vous avez le syndrome rachidien, le syndrome radiculaire et le syndrome sous-lésionnel lorsqu'il y a une atteinte des voies pyramidales. Et on termine par l'examen somatique. Alors l'examen rachidien, alors quel que soit l'étage, que ce soit l'orachis cervicale et l'orachis lombaire qui sont les plus souvent atteints, il faut chercher une attitude ontalgique qui peut être directe ou indirecte.

Directe, c'est-à-dire que la déviation du corbeau physiologique se fait du côté de la radiculergie. Ou indirecte, ça veut dire qu'il se fait du côté contrôle latéral. Il faut chercher l'arrêteur segmentaire.

Alors au niveau du orachis lombaire, c'est la distance d'oissons à l'indice de Schubert. Il y a également une manœuvre de Sperling que je vais vous montrer tout à l'heure. Il faut chercher des points douloureux au regard des épineuses, ce qu'on appelle le signe de la sonnette, c'est-à-dire que l'appui va réveiller la radiculergie lorsque j'appuie sur l'étage qui est atteint.

En exemple, lorsque j'appuie sur l'étage L4, L5, ça peut déclencher la radiculergie L5, de la sciétique L5. Le syndrome radiculaire, c'est-à-dire c'est l'ensemble des manifestations cliniques qui vont explorer la racine. Alors c'est une douleur, la douleur spontanée qui est provoquée à l'étirement des racines nerveuses par un certain nombre de manœuvres.

Au niveau du orachis lombaire, vous connaissez parfaitement la manœuvre Lasegg qui va déclencher la radiculergie L5 ou S1. La manœuvre LERI que je vais vous montrer sur une échographie permet de déclencher la radiculergie L3 et L4. Au niveau du orachis cervical, nous avons l'équivalent du Lasegg au membre supérieur qu'on appelle la manœuvre de Roger et Bikila.

Alors toujours dans le syndrome radiculaire, il faut chercher de manière systématique s'il y a des troubles de la sensibilité tactile, il faut voir s'il n'y a pas un déficit moteur et il faut explorer les réflexes oscillotenduleux en fonction de chaque métamère. Alors troisième partie avant l'examen somatique, c'est la recherche des syndromes sous-lésionnels. Le syndrome sous-lésionnel, lui, il est en rapport lorsque nous avons un processus qui va toucher la moelle épinière.

Moelle épinière, donc c'est-à-dire une atteinte des voies pyramidales. Et dans ce cas-là, il faut chercher le trouble sphactérien et le syndrome pyramidal. Les troubles sphactériens, pour rappel, en fait, ce sont les malades qui viennent avec des troubles urinaires à titre d'incontinence ou d'arrêtance aiguë des urines ou bien une incontinence anal.

Le syndrome pyramidal, lui, il est décrit par la spasticité, les réflexes oscillotenduleux qui sont vifs et polycynétiques et un belvinsky qui est positif en membres inférieurs. Sur le schéma de droite, vous voyez ici un exemple d'un processus en haut à droite. En haut à droite, nous avons un processus qui va donner uniquement une atteinte radiculaire.

Et juste à côté, du côté gauche, vous avez un processus qui va donner une atteinte radiculaire avec une atteinte médulaire. Alors dans le premier cas, on aura uniquement un syndrome radiculaire. Dans le deuxième cas, on aura un syndrome radiculaire et un syndrome sous-lésionnel.

Le syndrome sous-lésionnel, c'est la compression de la moelle épinière. Pour rappel, la moelle

épineuse s'arrête bien sûr au niveau L1/L2. Donc ce que vous voyez comme processus sur le schéma en bas, c'est le processus lésionnel qui comprime la racine.

On voit bien la racine, mais au sens où il n'y a plus de moelle, il y a la queue de cheval. Donc c'est une compression qui va donner un syndrome de la queue de cheval. Donc je résume encore une fois parce que c'est très important.

En haut à droite, vous avez un processus lésionnel qui va donner uniquement un syndrome radiculaire. À côté, à gauche, vous avez un processus qui est responsable du syndrome radiculaire et du syndrome médullaire, c'est-à-dire un syndrome sous-lésionnel. Et puis, vous avez le processus en bas qui est responsable de l'atteinte radiculaire et de la syndrome de la queue de cheval parce qu'il n'y a plus de moelle à ce niveau-là.

Donc vous voyez ici le syndrome rachidien. Donc on cherche bien sûr la raideur au niveau du rachis cervical. On peut observer un torticolis.

La manœuvre du spurlin, c'est-à-dire que le médecin va faire une compression axiale avec une rotation de la tête qui va déclencher la radiculopathie. Vous voyez ici les points douloureux au niveau du rachis cervical. Un exemple, l'attitude ontalgique avec un syndrome rachidien où la patiente se met en position ontalgique et peut être directe ou indirecte.

Le syndrome rachidien, donc, pour le rachis lombaire, surtout en calculant la distance d'un sol et l'indice de Schubert, vous avez ici la manœuvre du lasec, le malade étant du cubitus dorsal et le médecin va lever le membre inférieur qui est en extension et on calcule l'angle. Donc la manœuvre de lasec, on dit qu'un lasec est positif lorsque l'angle est compris entre 0 et 60 degrés. Au-delà de 60 degrés, on peut dire que le lasec est négatif.

On peut sensibiliser cette manœuvre du lasec en imprimant, comme vous le voyez sur le schéma au centre, une dorsiflexion du pied qui peut déclencher la radiculopathie. Et à droite, vous voyez la manœuvre de l'iris, le patient étant du cubitus ventral et le médecin va faire une rétropulsion de la hanche. Il va tirer sur la racine L3 ou L4 et il va déclencher une radiculopathie, ce qu'on appelle la manœuvre de l'iris, qui est l'équivalent du lasec pour la cinétique.

La deuxième étape, c'est le diagnostic topographique. Cette étape est essentielle pour la prise en charge du malade. Ça veut dire que vous voyez sur le schéma les métamères qui vont vous permettre de définir quel type de radiculopathie.

Alors L3, généralement, c'est sur la face antérieure de la cuisse. L4, sur la face antérieure de la cuisse, dépasse le genou et passe sur la partie interne de la jambe jusqu'à la malléole interne. L5, c'est la radiculopathie L5.

Vous avez essayé d'une atteinte au niveau de la fesse. La face postérieure de la cuisse, le mollet, derrière la malléole externe et qui passe, pardon, devant la malléole externe, devant la

magliole externe, sur le dos du pied et se termine au niveau du gros orteil. Et puis, la radiculalgie S1, qui fait la fesse, face postérieure de la cuisse, le mollet, passe derrière la magliole externe, le bord externe du pied et se termine au niveau du petit orteil.

A ce niveau-là, il faut retenir ce tableau parce qu'il permet d'explorer la topographie. L'abolition des réflexions oscillotendue, c'est en rapport avec une atteinte de la racine S1. Et l'abolition des réflexions rotulières, soit elle est due à l'atteinte de racine L4 ou bien L3.

Et vous voyez, en regard de ce tableau, quel type de difficile moteur il faut chercher. L'atteinte S1, c'est surtout la flexion plantaire et donc le patient ne peut pas marcher sur la pointe des pieds. L5, c'est surtout les extenseurs des orteils.

Et nous avons l'atteinte de L4, qui va donner une atteinte du quadriceps et la même chose pour la radiculopathie L3. Donc je réitère le fait que de faire marcher un patient qui a une radiculopathie L5 ou S1, lorsque vous avez une atteinte de S1, donc le patient ne peut pas faire la flexion plantaire, donc il ne peut pas marcher sur la pointe des pieds. L5, il n'arrive pas de faire l'extension des orteils et il ne peut pas marcher sur les talons.

Alors au niveau du membre supérieur, ici ce qui est le plus important, c'est de toujours de chercher bien sûr la métamère. Alors les névralgies cervicobraquiales C5 s'arrêtent au niveau du moignon de l'épaule. Les radiculopathies C6 vont se terminer au niveau du pouce et au niveau de l'index.

Les radiculopathies C7 vont se terminer au niveau surtout des majeurs. Les radiculopathies C6 et C8 vont se terminer au niveau du quatrième et cinquième orteils. Ça c'est très important pour le diagnostic topographique et il faut retenir les réflexes qui sont associés à l'atteinte.

Les névralgies cervicobraquiales C5, on aura une abolition du réflexe bicipital, le stylo radial pour C6, le tricipital pour C7 et le cubitopronateur pour une atteinte C8. La troisième étape, c'est l'orientation étiologique. C'est quelque chose de très important.

Après l'examen clinique, il faut savoir est-ce qu'on est devant une radiculopathie commune ou une radiculopathie symptomatique. En faveur d'une radiculopathie commune, la douleur et les mécaniques, il y a toujours un facteur déclenchant tel que le port d'un objet lourd, des antécédents similaires de cervicalgie ou de l'embalgie. La topographie de la radiculopathie, généralement, il touche un seul membre et une seule racine et lorsqu'on a une hernie discale, la douleur est impulsive.

L'impulsivité de la douleur est définie par l'accentuation de la douleur radiculaire à la toux et à la défécation. Dans les radiculopathies communes, il n'y a pas de fièvre. La raideur est segmentaire, il touche un seul segment.

Par exemple, au niveau du racisme cervicale, c'est la rotation du côté gauche. Il n'y a pas d'altération de l'état général et habituellement, les causes sont l'arthrose et la hernie discale. Les

radiculagies symptomatiques, la douleur est inflammatoire.

Habituellement, il n'y a pas de facteur déclenchant, il n'y a pas d'antécédent similaire. La topographie, ça peut toucher les deux membres, ça peut toucher plusieurs racines. La douleur n'est pas impulsive.

On peut trouver de la fièvre et la raideur est globale. Exemple, au niveau du rachisme cervicale, le malade se présente avec l'attitude guindée de la tête. Il ne peut faire ni rotation, ni flexion, ni extension.

Il y a habituellement une altération de l'état général et les radiculagies symptomatiques. Il faut chercher en priorité une infection disco-vertébrale qui est la spondylodiscite infectieuse, un rhumatisme inflammatoire chronique tel que la spondylarthrite ou une tumeur maligne primitive ou secondaire, c'est-à-dire métastase. La quatrième étape, savoir demander les examens complémentaires.

Les examens complémentaires, donc il faut demander un bilan inflammatoire, un bilan infectieux en fonction de l'étiologie que vous suspectez. Les imageries, on commence d'abord par une radiographie standard. Il faut savoir que le plus souvent, elle est normale, à moins qu'il montre une arthrose cervicale ou lombaire.

Parfois, dans certaines étiologies, par exemple, les métastatiques, on peut observer dans ces étiologies. C'est le scanner et l'IRM qui permettent de faire des diagnostics précoces. Pour les radiculagies communes, on peut mettre en évidence la hernie discale et la compression de cette racine par la hernie discale, ce qu'on appelle le conflit disco-radiculaire, et on peut mettre en évidence facilement les radiculagies symptomatiques lorsqu'il s'agit d'une infection ou d'une tumeur.

Si l'IRM actuellement, qui est la plus performante en matière d'exploration de radiculagies des membres, mais elle est moins disponible et plus coûteuse, c'est surtout pour les radiculagies symptomatiques lorsqu'on veut voir la nature du processus lésionnel infectieux aux métastatiques tumorales et son retentissement sur la racine et son retentissement sur la moelle épinière. Enfin, l'électromyogramme permet parfois, dans certaines situations douteuses, de mettre en évidence le degré de la souffrance de la racine et sa topographie exacte. Et on a besoin de ce électromyogramme, surtout dans les névralgies cervico-brachiales.

La quatrième étape, c'est de connaître un certain nombre de formes cliniques, les formes cliniques des radiculagies des membres. D'abord, les formes particulières. Il y a un certain nombre de formes particulières.

Les formes hyperalgiques, c'est-à-dire des formes hyper douloureuses qui ne cèdent pas, même pas à la morphine. Alors, une forme de névralgie cervico-brachiale ou une lombalgie osseuse hyperalgique, c'est une lombalgie osseuse qu'on n'arrive pas à calmer après plusieurs jours de

morphine par voie intraveineuse ou par voie orale. Et généralement, ce sont des candidats à la chirurgie.

La forme paralysante, c'est-à-dire c'est une forme où nous avons un testis musculaire qui est inférieur à 3. Donc, ce sont des urgences non chirurgicales. Une forme paralysante, qu'il soit une névralgie cervico-brachiale, une lombalgie ou une lombalgie osseuse paralysante, c'est une urgence non chirurgicale. Il faut opérer le malade rapidement dans les deux jours.

Il y a certaines formes topographiques. Nous avons le syndrome de la côte-cheval que vous avez vu tout à l'heure sur l'échographie. Nous avons une atteinte pluriradiculaire au membre inférieur.

Donc, c'est un malade qui va se présenter avec une paraplégie, avec des troubles sphinctériens et on va mettre en évidence une anesthésie en selle. Là aussi, le syndrome de la côte-cheval est une urgence non chirurgicale. Et enfin, nous avons le rare syndrome de Claude Bernard Horner.

Ce syndrome qui est en rapport avec la compression de la racine C8D1 avec atteinte du nerf sympathique cervicale et qui associe une anophthalmie amylosis amylosis et qui est en rapport avec, généralement, un processus tumoral situé au niveau de l'apex pilaire. Deuxième forme clinique, ce sont les formes étiologiques dont on a parlé tout à l'heure. Nous avons les formes communes qui représentent 90% des radiculaires du membre au niveau du rachis lombaire plus que le rachis cervical, c'est l'ARN discal, l'arthrose.

L'arthrose, c'est l'irritation ici de la racine nerveuse par un bec ostéophytique. On voit à droite l'ARN discal qui comprime la racine, à gauche, vous voyez les becs ostéophytiques au niveau du trou de conjugaison qui comprime la racine nerveuse. On voit très très bien que les ostéophytes qui se développent en antérieur ne compriment rien du tout.

C'est surtout les ostéophytes qui se développent en postérieur au niveau du trou de conjugaison. Et on voit cet aspect de trou de conjugaison en sablier ou en chiffre 8 qui est assez typique lorsqu'on fait des radiographies de 3 à 4 au niveau du rachis cervical ou lombaire. Les radiculergies symptomatiques, 10% de l'ensemble des radiculergies qu'on va classer de cette manière.

Alors d'abord la pathologie vertébrale, vous avez les infections, les spondylodécrites apyogènes ou tuberculeuses qu'on appelle le mal de pote. Vous avez la pathologie tumorale, ça peut être une pathologie tumorale maligne, primitive, comme le myélomultiple ou secondaire, c'est soit les métastases d'un cancer ostéophile ou ça peut être une pathologie tumorale bénigne ou bien la spondylarthrite. Après vous avez les pathologies intrarachidiennes.

La pathologie intrarachidienne c'est à dire qui se trouve au niveau du canal rachidien, ça peut être la tumeur nerveuse comme le lipiome ou le mélanome. Une pathologie épidurale, ça peut être une épidurite tumorale ou infectieuse. Une épidurite infectieuse comme le

méningoradiculite viral comme celle du zona ou du VIH, le sida, ou bien d'origine bactérienne comme la maladie de Lyme.

On peut observer parfois des pathologies épidurales lorsqu'on a un hématome ou une fibrose post-chirurgicale. Alors maintenant, la sixième étape, quels sont les diagnostics différentiels ? D'abord au membre supérieur. Alors au membre supérieur, les principaux diagnostics différentiels, c'est l'atteinte de l'épaule, de l'articulation de l'épaule, donc je vous laisse revoir votre cours sur l'épaule douloureuse, c'est un diagnostic différentiel qui se fait essentiellement avec la livrage du cerveau cobracal C5.

La pathologie osseuse, une pathologie de la clavicule, de l'homoplate, de l'humérus qu'on voit habituellement sur les radiographies standard. Les pathologies viscérales, il faut se méfier parce que là, ce sont des urgences. Toute pathologie cardiovasculaire peut se projeter au niveau de l'épaule, et c'est-à-dire au niveau du membre, surtout du membre supérieur en gauche.

L'angier de poitrine, l'infarctus du myocarde, la dissection de l'aorte, l'embolie pulmonaire, ou bien ce sont des pathologies pulmonaires, cancer bronchiques qui peuvent avoir des irradiations au niveau du membre supérieur. Bien sûr, dans ce cas-là, il n'y a pas de syndrome rachidien, l'examen neurologique est strictement normal. Et enfin, nous avons des pathologies neurologiques qui sont très rares, qui peuvent donner des douleurs au niveau du membre supérieur.

Vous avez la syringomyélie, certaines douleurs par atteinte cardinale postérieure ou des atteintes plexiques. Au membre inférieur, le diagnostic différentiel se fait entre l'embro-radicalgie L3, L4 ou sciatique avec une atteinte de l'articulation hanche-fémorale, la sacro-iliaque, une pathologie du genou, une pathologie de la cheville. Une pathologie osseuse qui peut toucher le bassin ou le fémur.

Il y a des tumeurs de fémur qui ont comprimé l'énergie sciatique, qui donnent une radicalgie du membre inférieur. Les pathologies vasculaires, il faut faire attention aux phlébites surales ou bien une ischémie aiguë lorsqu'on a une artéopathie oblitérante des membres inférieurs, d'où l'importance de l'examen somatique où il faut toujours faire la palpation du pouls périphérique et chercher s'il n'y a pas une tumeur de balotement des mollets en cas de phlébite. Et on voit quelquefois, parfois, les mêmes pathologies neurologiques qui sont plus rares, une polyneuropathie, une polyneuropathie diabétique, une douleur cervicale postérieure et la tumeur crânienne.

Enfin, la prise en charge thérapeutique. Alors pour les radicalgies symptomatiques, la prise en charge va être adaptée en fonction de la nature de la pathologie. Exemple, traitement antibactérien lorsque vous avez spondylites bactériennes, chimio-radiothérapie lorsque vous avez une métastase.

Alors maintenant, on passe pour la prise en charge thérapeutique des lombos radiculaires d'origine commune. Nous avons un certain nombre de moyens. Les moyens médicaux, nous

avons le repos d'abord.

Donc le repos doit être adapté, sa durée doit être adaptée à l'intensité de la douleur et de degrés de l'handicap. Par exemple, pour une lombo cignatique, c'est 10 à 15 jours de repos. Les ontalgiques, nous avons les paliers de l'OMS, le paracétamol 4 grammes par jour, le paracétamol associé à la codéine et les dérivés morphiniques.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens à dose efficace. Nous avons les antioxydants qui ont des AMM dans la douleur et qui sont mieux tolérés sur le plan digestif. Les quanticoïdes peuvent être administrés par voie orale, surtout dans l'anibavisavucobraquia à la dose de 40 à 60 mg par jour, avec une dégression rapide au moins de 3 semaines.

Les infiltrations rachidiennes de quanticoïdes au retard s'enfoncent sous scopie, uniquement au niveau du rachis lombaire. Chez une catégorie de patients, chez des malades qui résistent aux traitements médicaux, chez un malade pour lequel il y a eu une discussion avec le radiologue. Ils sont maintenant contre-indiqués pour l'anibavisavucobraquia.

Les myorlaxants, les antidépresseurs et les antiepileptiques qui ont une action ontalgique sur la composante neuropathique, surtout lorsqu'il s'agit d'une douleur neuropathique chronique. Alors les moyens physiques, nous avons l'immobilisation pour le rachis cervical, souvent un collier cervical, beaucoup moins qu'une mière, on utilise surtout le collier cervical, ou bien des ceintures d'immobilisation lombaire, qu'on appelle les lombostas, pour la douleur lombaire. La rééducation se fait, bien sûr, en dehors des crises douloureuses, et la chirurgie, il y a des indications qui sont actuellement bien précises.

On opère une radiculalgie, une radiculalgie du bord supérieur à inférieur, d'origine commune, en urgence, lorsqu'il s'agit d'une radiculalgie paralysante, lorsqu'il s'agit d'un syndrome de la clôture vale, lorsque nous avons un échec démorphinique, lorsque la radiculalgie est périlgique. Alors en dehors des urgences, on opère les patients lorsqu'il y a un échec d'un traitement médical bien conduit, pendant au moins 6 à 8 semaines. Alors les indications, toujours traitement médical bien conduit, suffisamment prolongé pour les radiculalgies d'origine commune, 2 mois, en gros, rééducation par la suite en dehors des crises, et puis les conseils d'hygiène vertébrale et d'éducation posturale pour la prévention des récives, en cas d'échec ou en cas de survenue de complication, c'est là où on adresse le patient au neurochirurgien.

Donc vous voyez ici une ethnographie qui montre une arthrose cervicale. Donc vous voyez ici une hernie discale sur un spinaire. Vous voyez ici une syringomyélie avec une malformation d'Arnold Kyrie.

Vous voyez ici une tumeur de l'apex qui donne le syndrome de Pancostobias avec le syndrome de Claude Bergeronner. Cette image montre un mal de pote et un spondylitis tuberculosa à l'étage C7-C6. Ici vous voyez un énorme neurinome.

On le voit très très bien sur l'IRM. On voit bien l'élargissement du trou de conjugaison dont il a été responsable. Ici vous voyez une arthrose lombaire sur un spinaire étagé.

Ici c'est une hernie discale lombaire avec un complot disco-radiculaire à l'étage L4-L5. Donc ce que vous voyez, c'est l'essuie. C'est une hernie discale et on ne voit plus la racine nerveuse du côté gauche, alors qu'elle est bien visible du côté droit.

Et vous voyez ici une hernie discale L5-S1 qui est énorme, qui est responsable d'un syndrome de la côte chauve-alle. Et vous voyez ici une spondylitis infectieuse avec des érosions en miroir, avec le fuseau qu'on voit de part et d'autre sur le cliché de face qui est la spondylodiscite tuberculeuse, le mal de pote. Et vous voyez ici une évolution à 3 mois d'une spondylodiscite infectieuse.

Donc la teinte ici est très vide. C'est pour ça que nous en sommes des urgences thérapeutiques. Ce que vous voyez ici, c'est un mal de pote dorsal lombaire, avec bien sûr l'abcès qui touche les petits molles.

Ce que vous voyez ici, c'est une métastase lombaire avec une compression médulaire. Et là, vous avez une métastase d'un cancer bronchique avec un syndrome de la côte chauve-alle avec une atteinte qui intéresse la vertèbre S5.